MEGTALÁLOD, ÉS TUDOD, MIT TEGYÉL™

60 kezelési protokoll izmonként

Az atlasz megmutatja, hol van a pont. Ez megmondja, mit csinálj vele: pozíció, technika, nyújtás, adagolás és otthoni teendő, izomról izomra.

Tartalom

1 · Általános elvek

2 · Fej, arc és nyak

3 · Váll, kar és kéz

4 · Hát és törzs

5 · Medence és csípő

6 · Comb, lábszár és lábfej

Következő lépés

1. RÉSZ

Általános elvek

Minden protokoll ezt a menetet követi.

Kinek szól

Oktatási anyag gyógytornászoknak, masszőröknek, oszteopatáknak, edzőknek és egészségügyi hallgatóknak. A protokollok a myofascialis triggerpontok kezelésének általánosan használt manuális technikáit foglalják össze. Nem helyettesítik az orvosi diagnózist, és nem írják felül a saját szakmai megítélésedet.

LÉPÉS	MIT CSINÁLSZ	MENNYI IDEIG
1. Keresés	Keresd meg a feszes köteget és benne a legérzékenyebb pontot (az atlasz kártyája szerint).	—
2. Ischaemiás kompresszió	Fokozatos, tartós nyomás a pontra, amíg a páciens 10-es skálán kb. 5–7-es kellemetlenséget jelez. Ha a feszülés enged, kövesd mélyebbre.	30–90 mp, 3–5 ismétlés
3. Nyújtás	Lassú, fájdalommentes nyújtás a kezelt izomra, kilégzésre.	3 × 20–30 mp
4. Aktív mozgás	A páciens néhányszor végigviszi az izmot a teljes mozgástartományán.	3–5 ismétlés
5. Otthonra	Adj egy egyszerű nyújtást vagy teendőt (lásd a protokoll alján).	naponta 1–2×

Mikor NE kezelj (és küldd orvoshoz)

Friss sérülés vagy duzzanat, láz, ismeretlen eredetű éjszakai fájdalom, zsibbadás vagy gyengeség, amely nem illik a kisugárzási mintázathoz, trombózis gyanúja, a terület bőrbetegsége. Véralvadásgátlót szedő páciensnél csak enyhe nyomást használj.

2. RÉSZ

Fej, arc és nyak

12 izom, az atlasz sorrendjében.

1. Trapezius – felső rostok

Musculus trapezius, pars descendens

HOL KERESD	A vállöv tetején, a nyak és az akromion között félúton, a felső szabad szélen.
KISUGÁRZÁS	halánték, a fej oldala, a nyak oldala, a fül mögött, állkapocsszöglet
PÁCIENS	Háton fekve, vagy ülve, a karok lazán az ölben.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a felső rostokon (hüvelyk- és mutatóujj), a feszes kötegen tartott ischaemiás kompresszió. • Alternatíva: lapos ujjbegyes nyomás a vállöv tetején.
NYÚJTÁS	Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe előrehajlítással; ülve a páciens ugyanazon oldali kezével fogja a szék alját.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp kompresszió, utána 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Oldalra döntéses nyújtás naponta kétszer; a monitor szemmagasságban; a telefont ne tartsa a fül és a váll között.

2. Sternocleidomastoideus (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

HOL KERESD	Az izomhas mentén, a sternalis és a clavicularis részen külön, a középső harmadban a legérzékenyebb.
KISUGÁRZÁS	homlok, a szem körül, arc, a fül mélyén, fejtető, nyakszirt
PÁCIENS	Háton fekve, a fej enyhén a kezelt oldal felé döntve, hogy az izom ellazuljon.
TECHNIKA	• Csak csipeszfogás: fogd meg az izomhasat két ujjal, és emeld el a nyak mély szerkezeteitől. • A sternalis és a clavicularis részt külön-külön kezeld, alulról felfelé haladva.
NYÚJTÁS	Fej az ellenkező oldalra döntve, majd az álla lassan a kezelt oldal felé fordul; enyhe hátrahajlítás csak akkor, ha nem okoz szédülést.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp csipeszkompresszió részenként, utána 2–3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Lassú fejbiccentés és -fordítás; fekve tévézés és felpolcolt fejjel olvasás kerülése.

Óvatosan: Az arteria carotis közvetlenül az izom alatt fut: soha ne nyomj hátrafelé a nyak elülső részén. Szédülés, hányinger vagy látászavar esetén azonnal hagyd abba.

3. Masseter (rágóizom)

Musculus masseter

HOL KERESD	A felületes rétegben a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett; a mély rétegben az állkapocsízület előtt.
KISUGÁRZÁS	felső és alsó őrlőfogak, állkapocs, szemöldök, a fül mélyén
PÁCIENS	Háton fekve, a száj kissé nyitva.
TECHNIKA	• Kívülről: lapos ujjbegyes kompresszió a járomív alatt és az állkapocsszöglet felett. • Belülről (kesztyűben): csipeszfogás, egyik ujj a szájban, a másik kívül; lassú, harántirányú dörzsölés.
NYÚJTÁS	Lassú szájnyitás a nyelv hegyével a szájpadláson; a terapeuta két ujja finoman segíti lefelé az állkapcsot.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp kompresszió, 2–3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Napi önmasszázs körkörösen; rágógumi kerülése; figyelni a nappali fogösszeszorításra.

> **Óvatosan:** Friss állkapocsízületi fájdalomnál vagy fogászati panasznál előbb fogorvosi vizsgálat. Szájon belül mindig kesztyűt használj.

4. Temporalis (halántékizom)

Musculus temporalis

HOL KERESD	Négy területen a járomív felett, elölről hátrafelé; rágás közben jól tapintható.
KISUGÁRZÁS	halánték, szemöldök, a szem mögött, felső fogak, a fej oldala
PÁCIENS	Háton fekve vagy ülve, a fogak enyhén szétnyitva.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes kompresszió a négy rostcsoporton a járomív felett, elölről hátrafelé. • A feszes kötegeken rostokra haránt, lassú dörzsölés.
NYÚJTÁS	Lassú szájnyitás, miközben a terapeuta ujjai felfelé simítanak a halántékon.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp pontonként, majd 3–5 lassú simítás.
OTTHONRA	Halántéktáji önmasszázs fejfájás kezdetén; az éjszakai fogcsikorgatás figyelése.

5. Pterygoideus lateralis

Musculus pterygoideus lateralis

HOL KERESD	Mélyen a járomív alatt; szájon belül a felső őrlőfogak mögött, felfelé és hátrafelé.
KISUGÁRZÁS	állkapocsízület, arc (arcüreg felett)
PÁCIENS	Háton fekve, a száj félig nyitva.
TECHNIKA	• Szájon belül, kesztyűben: kisujjal óvatos, lassú nyomás a felső őrlőfogak mögött. • Kívülről: kompresszió a járomív alatti mélyedésben, a száj nyitott állásában.
NYÚJTÁS	Az állkapocs lassú hátrahúzása (a páciens kissé hátrahúzza az állát), majd lassú szájzárás.
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp kíméletes nyomás, 2 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Kemény, nagy falatok kerülése; tudatos lassú szájnyitás egyenes vonalban.

Óvatosan: Szájon belül csak kesztyűben és nagyon finoman; fájdalmas kattogás vagy beakadás esetén fogorvos vagy szájsebész.

6. Pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus medialis

HOL KERESD	Az állkapocsszöglet belső oldalán, alulról tapintva; szájon belül az utolsó őrlőfog mögött.
KISUGÁRZÁS	a nyelv töve, torok, a fül alatt, állkapocsízület
PÁCIENS	Háton fekve, a fej enyhén a kezelt oldal felé fordítva.
TECHNIKA	• Kívülről: ujjbegyes nyomás az állkapocsszöglet belső felszínén, felfelé. • Szájon belül (kesztyűben): óvatos nyomás az utolsó őrlőfog mögött a szájpad felé.
NYÚJTÁS	Lassú szájnyitás, az állkapocs kissé az ellenkező oldalra tolva.
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp kompresszió, 2 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Fogösszeszorítás tudatos elengedése; puha étrend fájdalmas napokon.

Óvatosan: Nyelési fájdalom vagy torokpanasz esetén előbb orvosi vizsgálat.

7. Splenius capitis

Musculus splenius capitis

HOL KERESD	A nyak hátsó-oldalsó részén, a SCM és a trapezius között, a nyakszirt alatt kb. 2–3 ujjnyival.
KISUGÁRZÁS	fejtető
PÁCIENS	Háton fekve vagy hason, a fej középállásban.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes kompresszió a SCM és a trapezius közötti háromszögben, felfelé és befelé. • Hosszanti simítás a nyakszirt felé.
NYÚJTÁS	Fej előrehajlítva és az ellenkező oldalra fordítva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp kompresszió, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszan felfelé nézés (festés, polcpakolás) kerülése; jó párnamagasság.

8. Splenius cervicis

Musculus splenius cervicis

HOL KERESD	A nyak alsó részén, a lapocka felső szöglete felett, a levator scapulae mellett.
KISUGÁRZÁS	a szem mögött, nyakszirt, a nyak és a váll találkozása
PÁCIENS	Hason fekve, a homlok alátámasztva.
TECHNIKA	• Ujjbegyes kompresszió a nyak tövénél, a gerinc mellett oldalt. • Lassú harántirányú dörzsölés a feszes kötegen.
NYÚJTÁS	Fej előrehajlítva és az ellenkező oldalra döntve-fordítva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, utána 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Fej előretolt tartásának javítása; óránkénti mozgásszünet.

9. Suboccipitalis izmok

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

HOL KERESD	Közvetlenül a nyakszirtcsont alatt, a középvonal két oldalán, mélyen.
KISUGÁRZÁS	a fej oldala, a szem mögött, homlok, nyakszirt
PÁCIENS	Háton fekve, a terapeuta a fejnél ül.
TECHNIKA	• A terapeuta ujjbegyei a nyakszirtcsont alatt, a fej súlya adja a nyomást (suboccipitalis felengedés). • Várd meg, amíg a szövet enged, és az ujjak lassan mélyebbre süllyednek.
NYÚJTÁS	Állbehúzás (a fej egyenesen hátracsúszik), majd enyhe biccentés előre.
ADAGOLÁS	1–2 × 60–120 mp felengedés, utána 5–10 lassú állbehúzás.
OTTHONRA	Állbehúzás naponta 10×; a képernyő szemmagasságban; óránként rövid szünet.

> **Óvatosan:** Szédülés, látászavar, zsibbadás vagy nyelési nehézség esetén azonnal hagyd abba, és küldd a pácienst orvoshoz.

10. Semispinalis capitis

Musculus semispinalis capitis

HOL KERESD	A tarkón, a középvonal mellett 2–3 cm-re, a nyakszirt alatt és a nyak közepén.
KISUGÁRZÁS	a fej oldala, halánték, homlok, nyakszirt
PÁCIENS	Hason fekve, vagy háton a fej oldalra fordítva.
TECHNIKA	• Ujjbegyes kompresszió a gerinc mellett, lentről felfelé haladva. • Hosszanti simítás a nyakszirt felé.
NYÚJTÁS	Fej előrehajlítva, enyhe oldalra fordítással.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, utána 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Fej előretolt tartás kerülése; olvasáskor a könyv szemmagasságban.

11. Levator scapulae (lapockaemelő)

Musculus levator scapulae

HOL KERESD	A lapocka felső szöglete fölött kissé medialisan, és a nyak oldalán a trapezius felső szélének mélyén.
KISUGÁRZÁS	a nyak és a váll találkozása, a lapocka belső széle, a váll hátsó része
PÁCIENS	Hason fekve, vagy ülve, a kar lazán.
TECHNIKA	• Kompresszió a lapocka felső szöglete fölött, kissé medialisan. • Második pont: a nyak oldalán, a trapezius felső szélének mélyén.
NYÚJTÁS	Fej előre- és az ellenkező oldalra fordítva (orral a hónalj felé), a kezelt oldali kéz a tarkó mögött.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp kompresszió, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ugyanez a nyújtás naponta kétszer; magas párna és a fej oldalra fordítása munka közben kerülendő.

12. Scalenus izmok

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

HOL KERESD	A nyak oldalán, a SCM mögött és alatt, a kulcscsont felett.
KISUGÁRZÁS	mellkas eleje, felkar, a lapocka belső széle, a kéz (hüvelyk- és mutatóujj)
PÁCIENS	Háton fekve, a fej enyhén a kezelt oldal felé döntve.
TECHNIKA	• Lapos, nagyon finom ujjbegyes nyomás a SCM hátsó széle mögött, a kulcscsont felett. • Rövid, 20–30 mp-es tartások; a páciens mélyen lélegezzen hasba.
NYÚJTÁS	Fej az ellenkező oldalra döntve, enyhe hátrahajlítással; a kezelt oldali kulcscsontot a terapeuta lefelé rögzíti.
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp kíméletes nyomás, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hasi (rekeszizom-) légzés gyakorlása; nehéz táska vállon hordásának kerülése.

> **Óvatosan:** A plexus brachialis és az erek ezen a területen futnak: ha a karba zsibbadás vagy bizsergés sugárzik, csökkentsd a nyomást vagy hagyd abba. Tartós zsibbadásnál orvosi vizsgálat.

3. RÉSZ

Váll, kar és kéz

14 izom, az atlasz sorrendjében.

13. Infraspinatus

Musculus infraspinatus

HOL KERESD	A lapocka hátsó felszínén, a lapockatövis alatt, a fossa infraspinata középső és felső részén.
KISUGÁRZÁS	a váll eleje (mélyen), felkar elülső-oldalsó része, alkar, a kéz hüvelykujj felőli oldala
PÁCIENS	Hason fekve, vagy oldalt fekve a kezelt oldal felül.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes vagy hüvelykujjas kompresszió a lapocka hátsó felszínén. • Pontonként haladj a lapockatövistől lefelé.
NYÚJTÁS	A kezelt oldali kar a test előtt keresztben, a könyök a másik kézzel a mellkas felé húzva; vagy a kéz a hát mögött.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, utána 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Alvás a fájós oldalon kerülendő; a karra párna alátámasztás oldalt fekve.

14. Supraspinatus

Musculus supraspinatus

HOL KERESD	A lapockatövis felett, a fossa supraspinata medialis részén és laterálisan a vállcsúcs alatt.
KISUGÁRZÁS	a váll oldala (deltoid terület), a felkar külső oldala, a könyök külső oldala
PÁCIENS	Ülve vagy hason fekve.
TECHNIKA	• Mély ujjbegyes kompresszió a lapockatövis felett, a trapezius rostjain keresztül. • Laterálisan az ín közelében csak finom nyomás.
NYÚJTÁS	A kezelt oldali kéz a hát mögött, a másik kéz finoman húzza a csuklót az ellenkező oldal felé.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Nehéz tárgyak fej fölé emelésének kerülése; vállkörzés naponta.

> **Óvatosan:** Akut, éles vállfájdalom vagy éjszakai fájdalom, ami nem enged: rotátorköpeny-sérülés kizárására orvosi vizsgálat.

15. Teres minor

Musculus teres minor

HOL KERESD	A lapocka külső szélén, az infraspinatus alatt, a hónalj hátsó redője felett.
KISUGÁRZÁS	a váll hátsó része (pontszerűen), a felkar hátsó része
PÁCIENS	Hason fekve, a kar lelóg az ágy szélén, vagy oldalt fekve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás vagy hüvelykujjas kompresszió a lapocka külső szélén, a hónalj hátsó redője felett.
NYÚJTÁS	A kar a test előtt keresztben, a könyök a mellkas felé húzva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ugyanaz, mint az infraspinatusnál; a kar ne aludjon a fej fölött.

16. Subscapularis

Musculus subscapularis

HOL KERESD	A lapocka elülső felszínén, a hónaljból elérve, a lapocka külső széle mentén.
KISUGÁRZÁS	a váll hátsó része, a lapocka, a felkar hátsó része, a csukló
PÁCIENS	Háton fekve, a kar kb. 45°-ban távolítva és kifelé forgatva.
TECHNIKA	• A hónaljon át az ujjbegyekkel a lapocka elülső felszíne felé, nagyon lassan. • Rövid tartások, a páciens jelzése szerint.
NYÚJTÁS	Kar kifelé forgatva, könyök 90°-ban, a kezet finoman hátra engedve (ajtófélfánál).
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Kifelé forgatás gyakorlása; a kar ne maradjon sokáig a test mellé szorítva.

> **Óvatosan:** A hónaljban erek és idegek futnak: lassan, finoman haladj; zsibbadásnál engedj.

17. Deltoideus

Musculus deltoideus

HOL KERESD	Az elülső, középső és hátsó rostokban, a vállcsúcs alatt 2–5 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a váll (a pont körül), a felkar
PÁCIENS	Ülve vagy háton fekve.
TECHNIKA	• Lapos vagy csipeszkompresszió a három rostcsoporton külön. • Harántirányú dörzsölés a feszes kötegeken.
NYÚJTÁS	Elülső rostok: kar hátra; hátsó rostok: kar a test előtt keresztben.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp rostcsoportonként, 2–3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ismétlődő emelés közben szünetek.

18. Pectoralis major

Musculus pectoralis major

HOL KERESD	A mellizom külső szélén (hónalj elülső redője), a kulcscsont alatt és a szegycsont mellett.
KISUGÁRZÁS	a mellkas eleje, a váll eleje, a kar belső oldala, a mell
PÁCIENS	Háton fekve, a kar kissé távolítva.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a hónalj elülső redőjén. • Lapos kompresszió a kulcscsont alatt és a szegycsont mellett.
NYÚJTÁS	Ajtófélfa-nyújtás: alkar a kereten, könyök vállmagasságban, a test lassan előre lép.
ADAGOLÁS	3 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Görnyedt tartás javítása; vállak hátra-le.

Óvatosan: Bal oldali mellkasi fájdalomnál, főleg terheléskor, légszomjjal vagy verejtékezéssel: először szívpanaszt kell kizárni, sürgősen orvoshoz.

19. Pectoralis minor

Musculus pectoralis minor

HOL KERESD	A processus coracoideus alatt, a 3–5. borda felett, a pectoralis major alatt mélyen.
KISUGÁRZÁS	a váll eleje, a mellkas, a kar belső oldala, a kisujj felőli kéz
PÁCIENS	Háton fekve, a kar a test mellett.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes nyomás a pectoralis major alatt, a hónaljból befelé és felfelé. • Rövid tartások, lassú légzéssel.
NYÚJTÁS	Vállak hátra és le; ajtófélfánál a könyök a vállmagasság fölött.
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Előreesett váll javítása; a hátizmok erősítése.

Óvatosan: Ha a karba zsibbadás sugárzik, csökkentsd a nyomást.

20. Rhomboideus

Mm. rhomboidei major et minor

HOL KERESD	A lapocka belső széle és a gerinc között, a trapezius alatt.
KISUGÁRZÁS	a lapocka belső széle, a lapockák között
PÁCIENS	Hason fekve, a karok lazán az ágy mellett.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a lapocka belső széle mentén, fentről lefelé. • Harántirányú dörzsölés a rostokon.
NYÚJTÁS	Karok előre keresztben (önmagunk átölelése), a hát enyhén kerekítve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	A mellizom nyújtása (a rhomboideus gyakran túlnyújtott, gyenge).

21. Serratus anterior

Musculus serratus anterior

HOL KERESD	A mellkas oldalán, a hónalj alatt az 5–6. borda magasságában.
KISUGÁRZÁS	a mellkas oldala, a lapocka alsó csúcsa, a kar belső oldala
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül, a kar előre.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes nyomás a bordák között, a hónalj alatt. • Lassú simítás a bordák mentén.
NYÚJTÁS	Kar hátra és a lapocka a gerinc felé húzva; mély belégzés közben.
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Köhögés, intenzív futás után gyakori: fokozatos terhelés.

> **Óvatosan:** Légzéssel összefüggő éles oldalfájdalomnál, láznál vagy köhögésnél előbb orvosi vizsgálat.

22. Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

HOL KERESD	A hónalj hátsó redőjében, a lapocka alsó csúcsa magasságában.
KISUGÁRZÁS	a lapocka alsó csúcsa, a kar hátsó-belső oldala, a gyűrűs- és kisujj
PÁCIENS	Hason vagy oldalt fekve, a kar a fej fölé emelve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a hónalj hátsó redőjén. • Lapos kompresszió a lapocka alsó csúcsa mellett.
NYÚJTÁS	Kar a fej fölött, a törzs az ellenkező oldalra döntve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Felhúzódzkodás és húzó mozgások után nyújtás.

23. Biceps brachii

Musculus biceps brachii

HOL KERESD	A felkar elülső részének középső harmadában, mindkét fejben.
KISUGÁRZÁS	a váll eleje, a könyökhajlat
PÁCIENS	Háton fekve, a könyök enyhén hajlítva.
TECHNIKA	• Csipeszfogás az izomhason. • Lapos kompresszió a középső harmadban.
NYÚJTÁS	Könyök nyújtva, alkar befelé forgatva, a kar hátra.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Nehéz tárgyak hajlított könyökkel való cipelésének kerülése.

24. Triceps brachii

Musculus triceps brachii

HOL KERESD	A felkar hátsó részén, a hosszú fejben a hónalj alatt, és a könyök felett 4–6 cm-rel.
KISUGÁRZÁS	a váll hátsó része, a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala
PÁCIENS	Hason fekve, a kar lelóg, vagy háton a kar a fej fölött.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a hosszú fejen. • Lapos kompresszió a könyök felett.
NYÚJTÁS	Kar a fej fölött, a könyök teljesen hajlítva, a másik kéz finoman hátrafelé nyomja.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Mankóhasználatnál, fekvőtámasznál szünetek.

25. Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

HOL KERESD	Az alkar hátsó-külső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a könyök külső oldala, az alkar hátsó oldala, a kézhát, az ujjak
PÁCIENS	Ülve, az alkar az asztalon, tenyérrel lefelé.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a könyök alatti izomhasakon. • Harántirányú dörzsölés az izomhason (nem a csontos tapadáson).
NYÚJTÁS	Könyök nyújtva, csukló és ujjak hajlítva, a másik kéz finoman húzza lefelé.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Egérhasználat, csavarozás közben szünetek; szorítás csökkentése.

Óvatosan: Duzzanat, melegség vagy éjszakai zsibbadás esetén előbb orvosi vizsgálat.

26. Alkari hajlítók

Mm. flexores carpi et digitorum

HOL KERESD	Az alkar belső-elülső oldalán, a könyök alatt 3–6 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a csukló tenyéri oldala, a tenyér, az ujjak tenyéri oldala
PÁCIENS	Ülve, az alkar az asztalon, tenyérrel felfelé.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió az izomhasakon. • Hosszanti simítás a csukló felé.
NYÚJTÁS	Könyök nyújtva, tenyér felfelé, az ujjak hátrafelé húzva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Kézi munkánál (kertészkedés, szerelés) szünetek; markolás lazítása.

Óvatosan: Ujjakba sugárzó éjszakai zsibbadásnál (pl. kéztőalagút) orvosi vizsgálat.

4. RÉSZ

Hát és törzs

10 izom, az atlasz sorrendjében.

27. Trapezius – középső rostok

Musculus trapezius, pars transversa

HOL KERESD	A lapocka belső széle és a gerinc között, a lapockatövis magasságában, felületesen.
KISUGÁRZÁS	a lapockák között, a gerinc mellett égő érzés
PÁCIENS	Hason fekve, a karok az ágy mellett.
TECHNIKA	• Lapos hüvelykujjas kompresszió a lapocka belső széle mellett. • Harántirányú dörzsölés.
NYÚJTÁS	Karok előre keresztben, a hát kerekítve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Görnyedt ülés javítása; a mellizom nyújtása.

28. Trapezius – alsó rostok

Musculus trapezius, pars ascendens

HOL KERESD	A lapocka alsó csúcsa és a gerinc között, a középső hátban.
KISUGÁRZÁS	a nyak hátsó része, a vállcsúcs, a lapockák között
PÁCIENS	Hason fekve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás vagy hüvelykujjas kompresszió a lapocka alsó csúcsa mellett, medialisan.
NYÚJTÁS	Karok előre és fel, a hát kerekítve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Erősítés: hason fekve karemelés Y alakban.

29. Serratus posterior superior

Musculus serratus posterior superior

HOL KERESD	A lapocka felső része alatt, a gerinc mellett; a lapockát oldalra húzva érhető el.
KISUGÁRZÁS	a lapocka alatt mélyen, a váll hátsó része, a kar hátsó oldala, a kisujj
PÁCIENS	Ülve, a kezelt oldali kar a test előtt keresztben, hogy a lapocka elhúzódjon.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes kompresszió a lapocka felső-belső széle alatt, a bordán. • Rövid tartások, lassú légzéssel.
NYÚJTÁS	Kar előre keresztben, a hát kerekítve.
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Felső mellkasi (kapkodó) légzés helyett hasi légzés.

30. Iliocostalis thoracis

Musculus iliocostalis thoracis

HOL KERESD	A gerinc mellett kb. 5–8 cm-re, a középső és alsó háti szakaszon.
KISUGÁRZÁS	a hát közepe, a has (néha), a lapocka alatt
PÁCIENS	Hason fekve, a has alatt kis párna.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a gerincmerevítő külső szélén. • Hosszanti simítás lefelé.
NYÚJTÁS	Ülve előrehajlás, a törzs enyhén az ellenkező oldalra fordítva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszú ülés közben mozgásszünet.

Óvatosan: Hasi fájdalommal, lázzal, vizelési panasszal járó hátfájásnál előbb orvosi vizsgálat.

31. Iliocostalis lumborum

Musculus iliocostalis lumborum

HOL KERESD	Az ágyéki szakaszon a gerinc mellett kb. 5–7 cm-re, az alsó bordák alatt.
KISUGÁRZÁS	az ágyék, a fenék, a has alsó része
PÁCIENS	Hason fekve, a has alatt párna.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas vagy könyökös kompresszió a gerincmerevítő külső szélén.
NYÚJTÁS	Háton fekve térdek a mellkashoz húzva.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Emelés térdből, egyenes háttal; hosszú ülés megszakítása.

Óvatosan: Lábba sugárzó zsibbadás, gyengeség, vizelet- vagy székletürítési zavar: azonnal orvos.

32. Longissimus thoracis

Musculus longissimus thoracis

HOL KERESD	A gerinc mellett 2–4 cm-re, az alsó háti és felső ágyéki szakaszon.
KISUGÁRZÁS	a fenék, az ágyék, a csípőcsont taraja
PÁCIENS	Hason fekve.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a gerinc mellett, lentről felfelé.
NYÚJTÁS	Ülve előrehajlás, vagy háton térdek a mellkashoz.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ülő munka megszakítása óránként.

Óvatosan: Lábba sugárzó zsibbadásnál vagy gyengeségnél orvosi vizsgálat.

33. Multifidus

Musculus multifidus

HOL KERESD	Közvetlenül a tövisnyúlványok mellett, mélyen, bármely gerincszakaszon (leggyakrabban ágyéki).
KISUGÁRZÁS	a gerinc mellett pontszerűen, a keresztcsont, a has (ritkán)
PÁCIENS	Hason fekve, a has alatt párna.
TECHNIKA	• Mély, lassú hüvelykujjas kompresszió a tövisnyúlvány mellett, ferdén befelé.
NYÚJTÁS	Háton fekve térdek a mellkashoz, enyhe oldalra fordítással.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Mélyizom-aktiválás (hasprés nélküli has behúzás).

34. Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum

HOL KERESD	Az utolsó borda és a csípőcsont taraja között, a gerincmerevítő külső szélén, mélyen.
KISUGÁRZÁS	a csípőcsont taraja, a fenék, a csípő oldala, az ágyék
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül, a felső láb hátrafelé leengedve (a csípő-borda távolság nő).
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a gerincmerevítő szélén, befelé a gerinc felé. • Két pont: az utolsó borda alatt és a csípőcsont felett.
NYÚJTÁS	Állva vagy oldalt fekve oldalra döntés, a felső kar a fej fölött.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Egy lábon állás, egyoldali táskahordás kerülése.

Óvatosan: Vesetáji fájdalom lázzal vagy vizelési panasszal: előbb orvosi vizsgálat.

35. Rectus abdominis

Musculus rectus abdominis

HOL KERESD	A köldök felett és alatt, a középvonal mellett 2–4 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a hát közepe vízszintes sávban, a has, az ágyék
PÁCIENS	Háton fekve, a térdek alatt párna.
TECHNIKA	• Csipeszfogás vagy lapos kompresszió az izom szélén.
NYÚJTÁS	Háton fekve, egy párna a derék alatt, karok a fej fölött.
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Túlzott hasizomgyakorlás után nyújtás.

Óvatosan: Hasi fájdalom lázzal, hányással, széklet- vagy vizeletváltozással: orvosi vizsgálat, ne kezeld.

36. Obliquus externus abdominis

Musculus obliquus externus abdominis

HOL KERESD	A has oldalán, a bordaív alatt és a csípőcsont taraja felett.
KISUGÁRZÁS	a has oldala, az ágyék, a mellkas alja
PÁCIENS	Háton vagy oldalt fekve.
TECHNIKA	• Lapos ujjbegyes kompresszió a bordaív alatt. • Csipeszfogás a has oldalán.
NYÚJTÁS	Háton fekve, a térdek az ellenkező oldalra döntve, a vállak a földön.
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Csavaró mozgások fokozatos terhelése.

Óvatosan: Hasi panasznál előbb belgyógyászati okok kizárása.

5. RÉSZ

Medence és csípő

10 izom, az atlasz sorrendjében.

37. Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus

HOL KERESD	A fenék alsó-belső részén, a keresztcsont mellett és az ülőgumó felett.
KISUGÁRZÁS	a fenék, a keresztcsont, a farokcsont környéke
PÁCIENS	Hason fekve, vagy oldalt fekve.
TECHNIKA	• Könyökös vagy hüvelykujjas kompresszió a keresztcsont mellett és az ülőgumó felett.
NYÚJTÁS	Háton fekve, a térd az ellenkező váll felé húzva.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszú ülés megszakítása; kemény széken párna.

38. Gluteus medius

Musculus gluteus medius

HOL KERESD	A csípőcsont taraja alatt 2–5 cm-re, a fenék felső-külső részén.
KISUGÁRZÁS	az ágyék alja, a keresztcsont, a csípő oldala, a fenék
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a csípőcsont taraja alatt, elölről hátrafelé haladva.
NYÚJTÁS	Oldalt fekve a felső láb a test mögött lelóg az ágy szélén; vagy állva keresztezett lábbal oldalra dőlés.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Egy lábon állás, lábkeresztezés kerülése; csípőtávolító erősítés.

39. Gluteus minimus

Musculus gluteus minimus

HOL KERESD	Mélyen a gluteus medius alatt, a csípőcsont taraja és a combcsont nagy tompora között.
KISUGÁRZÁS	a comb külső oldala, a lábszár külső oldala, a comb hátsó része, a boka
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül, a felső térd alátámasztva.
TECHNIKA	• Mély, lassú hüvelykujjas vagy könyökös kompresszió a nagy tompor felett és előtt.
NYÚJTÁS	Háton fekve a láb az ellenkező oldalra keresztezve.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszú autózás, ülés megszakítása.

Óvatosan: A sugárzás az isiászra hasonlít: ha zsibbadás, gyengeség vagy reflexeltérés van, ideggyöki eredet kizárására orvosi vizsgálat.

40. Piriformis

Musculus piriformis

HOL KERESD	A keresztcsont külső széle és a nagy tompor csúcsa közötti vonal középső és külső harmadában.
KISUGÁRZÁS	a fenék, a keresztcsont, a comb hátsó része, a csípőízület hátsó része
PÁCIENS	Hason fekve, vagy oldalt fekve a felső térd behajlítva.
TECHNIKA	• Mély hüvelykujjas vagy könyökös kompresszió a keresztcsont és a nagy tompor közötti vonalon.
NYÚJTÁS	Háton fekve, a kezelt láb bokája a másik térdre téve, a másik comb a mellkas felé húzva (4-es nyújtás).
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ülés pénztárcán kerülése; lábkeresztezés kerülése.

Óvatosan: A nervus ischiadicus a közelben fut: zsibbadásnál csökkentsd a nyomást; tartós lábzsibbadásnál orvos.

41. Iliopsoas

Musculus iliopsoas

HOL KERESD	A comb elején a lágyékszalag alatt (a. femoralistól oldalra), és a hasban a csípőlapát belső oldalán.
KISUGÁRZÁS	az ágyék a gerinc mellett, a keresztcsont, a comb eleje
PÁCIENS	Háton fekve, a térdek felhúzva, hogy a hasfal lazuljon.
TECHNIKA	• Lassú, lapos ujjbegyes nyomás a csípőlapát belső oldalán, a has felől, kilégzésre. • A combon a lágyékszalag alatt, az ütőértől oldalra.
NYÚJTÁS	Kitörés-pozíció: a hátsó térd a földön, a csípő előre tolva.
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszú ülés után kitöréses nyújtás.

> **Óvatosan:** Az ütőér (pulzál) a közelben fut: soha ne nyomj rá. Hasi panasznál, terhességnél ne kezeld a hasi részt.

42. Tensor fasciae latae (TFL)

Musculus tensor fasciae latae

HOL KERESD	A csípő elülső-külső részén, a spina iliaca anterior superior alatt.
KISUGÁRZÁS	a comb külső oldala, a térd külső oldala
PÁCIENS	Háton vagy oldalt fekve.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a csípőcsont elülső csúcsa alatt és oldalt.
NYÚJTÁS	Oldalt fekve a felső láb nyújtva, hátra és lefelé engedve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ülés közben a combok ne legyenek erősen hajlítva.

43. Adductor longus

Musculus adductor longus

HOL KERESD	A comb belső oldalán, a felső harmadban.
KISUGÁRZÁS	a lágyék, a comb belső oldala, a térd belső oldala
PÁCIENS	Háton fekve, a térd hajlítva és kifelé engedve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás az izomhason. • Lapos kompresszió a comb belső oldalán.
NYÚJTÁS	Ülve talpak összeérintve (pillangó), a térdek lefelé engedve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hirtelen oldalirányú mozgások előtt bemelegítés.

44. Adductor magnus

Musculus adductor magnus

HOL KERESD	A comb belső-hátsó oldalán, a középső harmadban, és az ülőgumó közelében.
KISUGÁRZÁS	a lágyék, a comb belső oldala, a medence mélye
PÁCIENS	Háton fekve, a térd hajlítva és kifelé engedve, vagy oldalt fekve.
TECHNIKA	• Lapos kompresszió a comb belső-hátsó oldalán.
NYÚJTÁS	Ülve terpeszben előrehajlás.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Fokozatos terhelés, bemelegítés.

Óvatosan: Kismedencei vagy nőgyógyászati panasznál előbb orvosi vizsgálat.

45. Pectineus

Musculus pectineus

HOL KERESD	A comb belső-elülső részén, a lágyékhajlat alatt, az a. femoralistól befelé.
KISUGÁRZÁS	a lágyék mélyen, a comb belső-elülső része
PÁCIENS	Háton fekve, a láb kissé távolítva és kifelé forgatva.
TECHNIKA	• Lassú, lapos ujjbegyes nyomás a lágyékhajlat alatt, befelé az ütőértől.
NYÚJTÁS	Láb távolítva és nyújtva, enyhén hátra.
ADAGOLÁS	2–3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Ülés közben a combok ne legyenek összeszorítva.

Óvatosan: Az ütőér, a véna és a lágyéki nyirokcsomók közel vannak: finoman, és soha ne a pulzáló területen.

46. Sartorius

Musculus sartorius

HOL KERESD	A comb elején ferdén, a csípőcsont elülső csúcsától a térd belső oldaláig, felületesen.
KISUGÁRZÁS	a comb eleje (égő, szúró érzés), a térd belső oldala
PÁCIENS	Háton fekve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a vékony izomszalagon, felülről lefelé haladva.
NYÚJTÁS	Csípő nyújtva, enyhén befelé forgatva (kitörés-pozíció).
ADAGOLÁS	3 × 20–30 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Törökülés tartós kerülése.

6. RÉSZ

Comb, lábszár és lábfej

14 izom, az atlasz sorrendjében.

47. Rectus femoris

Musculus rectus femoris

HOL KERESD	A comb elején, közvetlenül a csípő alatt, a spina iliaca anterior inferior közelében.
KISUGÁRZÁS	a térd eleje, a térdkalács körül
PÁCIENS	Háton fekve.
TECHNIKA	• Lapos vagy csipeszkompresszió a comb felső elülső részén.
NYÚJTÁS	Hason fekve vagy állva a sarok a fenék felé húzva, a csípő nyújtva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Lépcsőzés, guggolás fokozatos terhelése.

48. Vastus medialis

Musculus vastus medialis

HOL KERESD	A comb belső-elülső oldalán, a térd felett 5–10 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a térd belső oldala, a térd eleje
PÁCIENS	Háton fekve, a térd alatt kis párna.
TECHNIKA	• Lapos hüvelykujjas kompresszió a térd felett belül.
NYÚJTÁS	Térd teljesen hajlítva (sarok a fenékhez).
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Erősítés: ülve térdnyújtás tartással.

49. Vastus lateralis

Musculus vastus lateralis

HOL KERESD	A comb külső oldalán, több ponton a csípő és a térd között.
KISUGÁRZÁS	a comb külső oldala, a térd külső oldala, a térdkalács mögött
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül.
TECHNIKA	• Könyökös vagy hüvelykujjas kompresszió a comb külső oldalán, lentről felfelé.
NYÚJTÁS	Térd teljesen hajlítva, a láb enyhén befelé forgatva.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Oldalt fekvés a fájós oldalon kerülendő.

50. Biceps femoris

Musculus biceps femoris

HOL KERESD	A comb hátsó-külső részén, a középső és alsó harmadban.
KISUGÁRZÁS	a térdhajlat, a comb hátsó része
PÁCIENS	Hason fekve, a boka alatt párna.
TECHNIKA	• Csipeszfogás vagy hüvelykujjas kompresszió a comb hátsó-külső oldalán.
NYÚJTÁS	Háton fekve egyenes láb emelése, a boka felhúzva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Hosszú ülés közben a szék éle ne nyomja a combot.

51. Semitendinosus / semimembranosus

Mm. semitendinosus et semimembranosus

HOL KERESD	A comb hátsó-belső részén, a középső és alsó harmadban.
KISUGÁRZÁS	a fenék alsó része, a comb hátsó része, a térdhajlat belső oldala
PÁCIENS	Hason fekve.
TECHNIKA	• Csipeszfogás a comb hátsó-belső oldalán.
NYÚJTÁS	Háton fekve egyenes láb emelése, enyhén kifelé.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Bemelegítés futás előtt.

52. Gastrocnemius

Musculus gastrocnemius

HOL KERESD	A vádli felső részén, a belső és külső fejben, a térdhajlat alatt.
KISUGÁRZÁS	a lábboltozat, a vádli, a térdhajlat
PÁCIENS	Hason fekve, a boka alatt párna.
TECHNIKA	• Csipeszfogás vagy hüvelykujjas kompresszió mindkét fejen.
NYÚJTÁS	Állva a falnál, a hátsó láb nyújtva, a sarok a földön.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Éjszakai görcsnél esti nyújtás; elegendő folyadék.

> **Óvatosan:** Egyoldali vádliduzzanat, melegség, pirosság (trombózis gyanúja): ne masszírozd, azonnal orvos.

53. Soleus

Musculus soleus

HOL KERESD	A vádli alsó részén, mélyen, a gastrocnemius alatt, az Achilles-ín felett.
KISUGÁRZÁS	a sarok, a vádli, a keresztcsont (ritkán)
PÁCIENS	Hason fekve, a térd 90°-ban hajlítva.
TECHNIKA	• Lapos kompresszió a vádli alsó részén, mindkét oldalról.
NYÚJTÁS	Állva a falnál, a hátsó térd enyhén hajlítva, a sarok a földön.
ADAGOLÁS	3–5 × 30–90 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Magas sarkú cipő kerülése.

Óvatosan: Egyoldali vádliduzzanat vagy melegség esetén ne kezeld: trombózis kizárására orvos.

54. Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior

HOL KERESD	A sípcsont mellett kívül, a lábszár felső harmadában.
KISUGÁRZÁS	a boka eleje, a nagylábujj
PÁCIENS	Háton fekve.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió az izomhason, a sípcsont mellett.
NYÚJTÁS	Boka és lábujjak lefelé feszítve (ülve a lábfej talppal felfelé maga alá hajtva).
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20–30 mp nyújtás.
OTTHONRA	Fokozatos futásterhelés; kemény talajon kevesebb futás.

Óvatosan: Erős, terheléskor fokozódó sípcsontfájdalom (fáradásos törés gyanúja) esetén orvosi vizsgálat.

55. Peroneus (fibularis) longus

Musculus fibularis longus

HOL KERESD	A lábszár külső oldalán, a felső harmadban, a fibulafej alatt 2–4 cm-re.
KISUGÁRZÁS	a külboka, a lábfej külső oldala
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt oldal felül.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a lábszár külső oldalán.
NYÚJTÁS	Lábfej befelé fordítva és lefelé feszítve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Bokastabilizáló gyakorlatok egy lábon állva.

Óvatosan: A nervus peroneus a fibulafej mögött fut: ott ne nyomj.

56. Tibialis posterior

Musculus tibialis posterior

HOL KERESD	Mélyen a vádli alatt, a sípcsont belső-hátsó széle mögött.
KISUGÁRZÁS	az Achilles-ín, a sarok, a talp
PÁCIENS	Hason fekve, a térd hajlítva.
TECHNIKA	• Mély, lassú kompresszió a sípcsont belső-hátsó széle mögött.
NYÚJTÁS	Lábfej kifelé fordítva és felhúzva.
ADAGOLÁS	2–3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Megfelelő boltozattámasz; lúdtalp esetén szakember.

57. Extensor digitorum longus

Musculus extensor digitorum longus

HOL KERESD	A lábszár elülső-külső részén, a tibialis anterior mellett kívül, a felső harmadban.
KISUGÁRZÁS	a lábfej háta, a középső lábujjak
PÁCIENS	Háton fekve.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a lábszár elülső-külső oldalán.
NYÚJTÁS	Lábujjak és boka lefelé feszítve.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Szűk cipő kerülése.

58. Flexor digitorum brevis

Musculus flexor digitorum brevis

HOL KERESD	A talp közepén, a sarok előtt.
KISUGÁRZÁS	a talp közepe, a lábujjtövek
PÁCIENS	Hason fekve, a lábfej az ágy végén.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a talp közepén. • Labdás vagy ujjperces lassú simítás.
NYÚJTÁS	Lábujjak felfelé húzva, a boka felhúzva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Megfelelő cipő; talpmasszázs labdával.

> **Óvatosan:** Reggeli első lépésekkor éles sarokfájdalom (talpi bőnye-gyulladás) esetén orvos vagy szakember.

59. Abductor hallucis

Musculus abductor hallucis

HOL KERESD	A talp belső szélén, a sarok és a nagylábujj töve között.
KISUGÁRZÁS	a sarok belső oldala, a lábboltozat belső széle
PÁCIENS	Oldalt fekve, a kezelt láb belső oldala felül.
TECHNIKA	• Hüvelykujjas kompresszió a talp belső szélén.
NYÚJTÁS	Nagylábujj befelé (a többi felé) húzva, a boka felhúzva.
ADAGOLÁS	3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Széles orrú cipő; nagylábujj-erősítés.

60. Quadratus plantae

Musculus quadratus plantae

HOL KERESD	A talp hátsó részén, mélyen, közvetlenül a sarokcsont előtt.
KISUGÁRZÁS	a sarok talpi felszíne
PÁCIENS	Hason fekve, a lábfej az ágy végén.
TECHNIKA	• Mély, lassú hüvelykujjas kompresszió a sarok előtt.
NYÚJTÁS	Lábujjak és boka felhúzva.
ADAGOLÁS	2–3 × 30–60 mp, 3 × 20 mp nyújtás.
OTTHONRA	Talpmasszázs labdával, kényelmes cipő.

Óvatosan: Duzzanat, zsibbadás vagy éjszakai sarokfájdalom esetén orvosi vizsgálat.

Következő lépés

Ma: olvasd el az általános elveket. **Holnap:** a következő nyak- vagy vállpanaszos páciensnél kövesd a trapezius és a levator scapulae protokollját, és jegyezd fel, mit tapasztaltál.